

Bronchite aigue



Dr. Alioua Amina

Maître assistante en pneumophtisiologie

Centre Hospitalo-Universitaire de
Constantine



Objectifs

- ☐ Définir une bronchite aiguë
- ☐ Connaître les germes en cause
- ☐ Savoir différencier une bronchite aiguë d'une pneumonie
- ☐ Traiter une bronchite aiguë

Plan

- ☐ Définition
- ☐ Epidémiologie
- ☐ Physiopathologie
- ☐ Agent causal
- ☐ Diagnostic positif
- ☐ Evolution
- ☐ Traitement
- ☐ Conclusion



Définition

- ❑ Inflammation aiguë des bronches et bronchioles (voies de conduction), le plus souvent de nature infectieuse, sans atteinte du parenchyme pulmonaire et notamment des alvéoles (surface d'échange)
- ❑ C'est une pathologie banale bénigne
- ❑ Diagnostic purement clinique



Epidémiologie

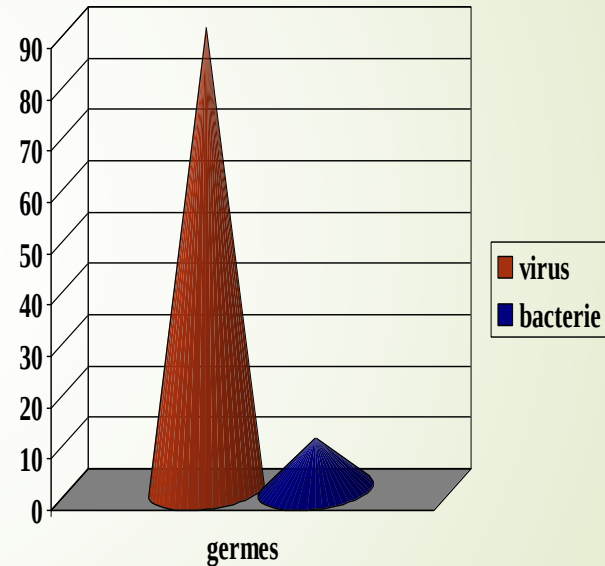
- ❑ Très fréquente (environ 10 millions de cas/an en France)
- ❑ Mode de survenue : épidémie saisonnière , automno-hivernale++.
- ❑ D'origine virale 90%
- ❑ L'évolution est bénigne
- ❑ Potentiel grave : âges extrêmes , comorbidités

Physiopathologie

- ❑ Inflammation aiguë de la muqueuse des VAI :
 - Destructures épithéliales de la muqueuse bronchique ➡ Ulcération de la membrane basale :
 - ➡ exposition des terminaisons nerveuses + récepteurs broncho constricteurs ➡ hyperréactivité bronchique (Toux + bronchoconstriction)
 - Hypersécrétion sero-muqueuse
 - Œdème inflammatoire de la muqueuse avec infiltration de polynucléaires.
- ❑ Restitution ad integrum en 15 jours

Agent causal

- ☐ Virus +++ 90%
 - rhinovirus,
 - influenza,
 - para-influenza,
 - Adénovirus
 - virus respiratoire syncytial,
 - métapneumovirus humain
 - Corona virus
- ☐ Bactéries



Les virus

➤ Les virus

- Corona virus
- Rhino virus
- Adénovirus



Infections des voies aériennes
Supérieures associée à une bronchite

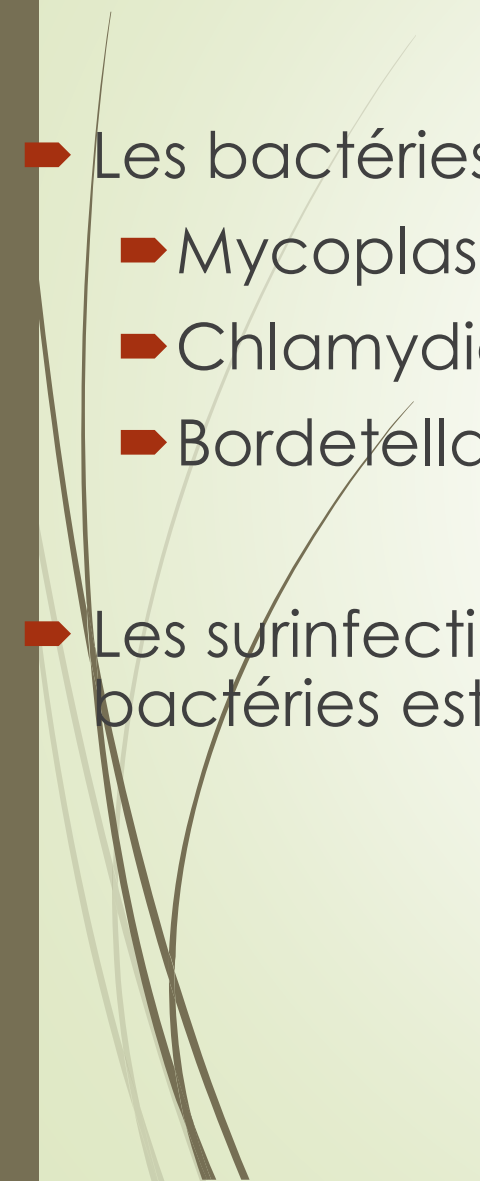
- Les virus influenza A,B
- Para influenza
- VRS



Bronchite prédominante

Les bactéries



- Les bactéries atypiques 5%
 - Mycoplasme pneumonie
 - Chlamydia pneumonie
 - Bordetella pertussis
 - Les surinfections de bronchite virale Par d'autres bactéries est possible
- 



Diagnostic positif

- ❑ Purement clinique ++
- ❑ Début :
 - Coryza rhino-pharyngé,
 - Pharyngite
- ❑ Puis signes d'irritation trachéo-bronchique :
 - le maître symptôme c'est la toux ++
 - Quinteuse sèche initialement douloureuse
 - Brûlures rétro-sternales dessinant l'arbre bronchique

Diagnostic positif

- ❑ Contexte fébrile 38°C avec symptômes viraux (Céphalées, myalgies, arthralgies.)
- ❑ En quelques jours, phase humide en fonction de l'importante de l'inflammation trachéo-bronchique.
- ❑ L' auscultation:
 - Normal
 - Râles bronchiques bilatéraux. Parfois des sibilants.
 - Pas de signe de foyer parenchymateux +++
- ❑ Examen para clinique
 - Radio du thorax n'est pas nécessaire sauf si suspicion d'une pneumonie
 - Analyse bactériologique de l'expectoration est inutile

Diagnostic positif

La discordance entre les signes fonctionnels (plaintes) et physiques quasi absents (pas de polypnée, pas de foyer, aucun signe de gravité) ++++



Evolution

- ❑ Généralement simple, avec une régression en quelques jours des symptômes. **Guérison spontanée**
- ❑ Parfois toux quinteuse pendant quelques semaines « **post-virale** ».
- ❑ Si persistance ou aggravation des symptômes reconsidérer le diagnostic (bilan complémentaire)
- ❑ Parfois surinfection bactérienne
- ❑ L'évolution peut être grave chez les sujets fragilisés, porteurs d'une comorbidité

Diagnostic différentiel

Pneumonie : La clinique permet habituellement de différencier la bronchite aiguë d'une pneumonie ;

Tableau comparatif des signes cliniques d'une Bronchite aiguë vs pneumonie.

Signes Suggestifs de bronchite :	Signe suggestifs de pneumonie :
-fièvre en général peu élevé	-fièvre > 37,8 °C
-brulure retro sternale	-Tachycardie > 100/min
-toux parfois précédée d'infection des voies respiratoire hautes	-Polypnée >> 25/min
-auscultation normale ou râles bronchiques diffus.	-douleur thoracique
	-absence d'infection des voies respiratoires hautes
	-signes auscultatoires en foyer (râles crépitants)
	-Impression globale de gravité.

Traitement

❑ Symptomatique :

- antalgique et/ou antipyrétique, antitussif en cas de toux sèche insomniente ou émétisante,
- mucolytiques ou fluidifiants bronchique si toux productive

❑ Abstention de prescrire les antibiothérapie est la règle chez l'adulte sain.

❑ L'indication éventuelle d'une antibiothérapie dans les suites d'une bronchite aiguë qui se complique passe par la mise en évidence d'un autre diagnostique (sinusite, pneumopathie..)

Prise en charge

Bronchite aiguë de l'adulte

1

Pas de radiographie pulmonaire

Pas d'antibiotique

Traitement symptomatique :

antipyrétique ± antitussif

± décongestionnant local ± fluidifiant bronchique

2

3

4

Évaluation de l'efficacité du traitement

Évolution favorable

- fièvre < 1 semaine
- toux et expectoration < 4 semaines

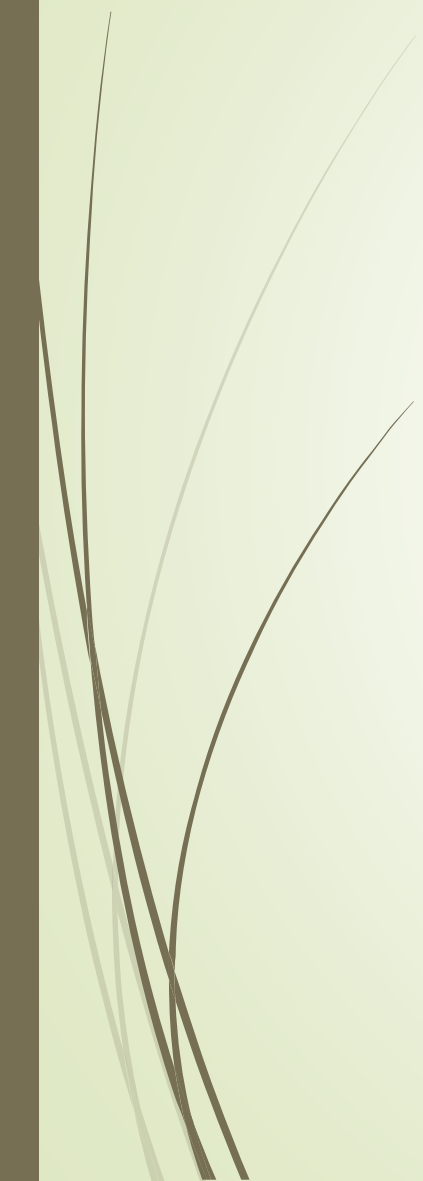
Persistance
ou aggravation
des symptômes

5

Recherche d'un autre diagnostic :
examen clinique et examens complémentaires



Conclusion



- ❑ La bronchite aiguë est virale dans $> 90\%$ des cas
- ❑ Diagnostiquer la bronchite aiguë principalement par la clinique
- ❑ Un télé thorax et/ou d'autres examens uniquement en cas de manifestations graves de la maladie.
- ❑ Traiter la plupart des patients seulement pour soulager les symptômes.